Masterprompt:

Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von Akzeptanz von KI-gestützten Systemen bei medizinischen Behandlungen bei Patientinnen und Patienten. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.
Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme bei der eigenen Behandlung. Gemessen werden die Nutzungsabsicht und die Faktoren, die sie beeinflussen.
Arbeitsschritte
Arbeite diese Schritte der Reihe nach ab:

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien und begründe die Wahl.
2. Modell: Leite ein Modell ab. Formuliere jeden Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese mit Richtung (+/−) und Quelle. Die Richtung stammt aus der in der Quelle formulierten Hypothese, nicht aus dem empirischen Ergebnis.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf.
4. Items: Erstelle je Konstrukt 3 bis 5 Items.

Theorievergleich
Liste in Schritt 1 alle Theorien aus den Quellen auf. Prüfe für jede, wie gut sie zur Zielgröße passt, und begründe, warum du sie aufnimmst oder nicht. Gib den Vergleich unter „Theorie und Begründung“ aus.
Konstrukttreue
Übernimm Konstrukte so, wie die Quelle sie misst. Getrennt gemessene Konstrukte oder Unterdimensionen bleiben getrennt, keine Sammelkonstrukte. Lass kein Konstrukt einer aufgenommenen Theorie ohne Begründung weg. Neu formulierte Items fragen genau einen Sachverhalt ab.
Perspektive
Formuliere alle Items in der Ich-Form und bezogen auf sich selbst, nicht aus Sicht der Organisation (z. B. „wir“, „unser Unternehmen“).
Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, deren Itemtexte in den Quellen abgedruckt sind. Ein Verweis wie „Items adaptiert aus …“ zählt nicht. Anpassen darfst du nur Gegenstand, Perspektive und Sprache. Übersetze sinngleich ins Deutsche. Sonst bleibt der Wortlaut gleich: nichts hinzufügen, nichts weglassen, nichts zusammenlegen. Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl. Verwende für den Gegenstand überall dieselbe Bezeichnung. Quelle je Item: Fragebogen oder Paper und Item-Kennung, nur wenn sie in der Quelle steht. Erfinde keine Kennungen. Kein Originaltext. Itemzahl je Skala: 3–5 Items: alle. Mehr als 5: die ersten 5. Weniger als 3: alle, mit neu formulierten auf 3 auffüllen. Keine passende Skala: Items neu formulieren. Markierungen: „neu formuliert“ (ohne Quelle); „(übersetzt)“ nur bei übersetztem abgedrucktem Itemtext; „(invers)“ nur, wenn das Item in der Originalskala negativ formuliert ist. Prüfe vor der Ausgabe: Steht der Originalwortlaut jedes Items mit Quelle in den Quellen? Wenn nicht, markiere es als „neu formuliert“. Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.
Ausgabeformat
Gib nur diese vier Teile in dieser Reihenfolge aus, sonst nichts:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Tabelle: Konstrukt | Item | Antwortskala, ein Item pro Zeile

Ausgabelänge
Nenne die Antwortskala einmal über der Tabelle, die Spalte Antwortskala entfällt. Begründe jede Theorie in höchstens zwei Sätzen. Kürze bei Bedarf Begründungen, nie Konstrukte oder Items.

Response:

1. Theorie und Begründung

- Health Belief Model (HBM): Das Health Belief Model fokussiert auf gesundheitsbezogene Bedrohungswahrnehmungen und präventive Verhaltensweisen von Patienten, lässt jedoch technologische Akzeptanzfaktoren von Informationssystemen unberücksichtigt. Es wird daher nicht als alleinige Theorie gewählt, liefert jedoch wesentliche Bausteine für den krankheitsbezogenen Pfad des integrierten Modells.
- Extended Parallel Process Model (EPPM): Das EPPM erklärt kognitive und emotionale Reaktionen (Gefahren- und Furchtkontrolle) auf gesundheitliche Bedrohungen, beinhaltet jedoch keine spezifischen Akzeptanzkonstrukte für Informationstechnologien. Es wird nicht isoliert angewendet, bildet aber das theoretische Fundament für die Dualitätsstruktur des integrierten Modells.
- Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2): Die UTAUT2 bietet eine fundierte Basis zur Erfassung der technologischen Akzeptanz und Effizienzeinschätzungen, ignoriert dabei jedoch krankheitsspezifische Bedrohungen und gesundheitliche Erwägungen der Patientinnen und Patienten. Sie wird nicht einzeln herangezogen, dient aber als Grundlage für die technologiebezogenen Konstrukte im integrierten Modell.
- Reasoned Action Approach (RAA): Der RAA (inkl. TPB) erklärt Verhaltensabsichten präzise über Einstellungen, soziale Normen und Verhaltenskontrolle, deckt jedoch weder spezifische technologische Eigenschaften noch gesundheitliche Bedrohungslagen ab. Er wird nicht als Solotheorie genutzt, geht aber strukturell in das integrierte Modell ein.
- Protection Motivation Theory (PMT) / Integriertes theoretisches Modell: Die PMT führt über den Dualitätsansatz sowohl krankheitsbezogene Risikobewertungen (Bedrohung) als auch technologiebezogene Bewältigungsbewertungen (Effizienz) zusammen und erklärt im Verbund mit den übrigen Ansätzen die Nutzungsabsicht am umfassendsten. Dieses integrierte Modell wird daher als theoretische Grundlage ausgewählt.

---

2. Modell mit Hypothesen

- H1a: Wahrgenommene Bedrohung → Furcht vor der Krankheit (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H1b: Wahrgenommene Bedrohung → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H2a: Fehlanpassungsbelohnungen → Furcht vor der Krankheit (−), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6

- H2b: Fehlanpassungsbelohnungen → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H3: Furcht vor der Krankheit → Einstellung zur Krankheit (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H4: Einstellung zur Krankheit → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H5a: Wahrgenommene Effizienz → Furcht vor dem KI-System (−), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H5b: Wahrgenommene Effizienz → Einstellung zum KI-System (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H5c: Wahrgenommene Effizienz → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H6: Furcht vor dem KI-System → Einstellung zum KI-System (−), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H7: Einstellung zum KI-System → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H8a: Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Bedrohung (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H8b: Wahrgenommene Normen → Furcht vor der Krankheit (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H8c: Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Effizienz (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H8d: Wahrgenommene Normen → Einstellung zum KI-System (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H8e: Wahrgenommene Normen → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H8f: Wahrgenommene Normen → Einstellung zur Krankheit (−), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H8g: Wahrgenommene Normen → Furcht vor dem KI-System (−), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H8h: Wahrgenommene Normen → Fehlanpassungsbelohnungen (−), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H9a: Fähigkeiten bezüglich des KI-Systems → Wahrgenommene Effizienz (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H9b: Fähigkeiten bezüglich des KI-Systems → Furcht vor dem KI-System (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H9c: Fähigkeiten bezüglich des KI-Systems → Einstellung zum KI-System (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H9d: Fähigkeiten bezüglich des KI-Systems → Wahrgenommene Kosten/Barrieren (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H9e: Fähigkeiten bezüglich des KI-Systems → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H10a: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Wahrgenommene Effizienz (−), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H10b: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Einstellung zum KI-System (−), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6
- H10c: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Paper Fragebogen 1.pdf, S. 6

3. Liste der Konstrukte

1. Nutzungsabsicht (Intention to use)
2. Einstellung zum KI-System (Attitude - HIS)
3. Furcht vor dem KI-System (Fear - HIS)
4. Wahrgenommene Antworteffizienz (Perceived response efficacy)
5. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Perceived behavioral control)
6. Wahrgenommene Normen (Perceived norms)
7. Einstellung zur Krankheit (Attitude - disease)
8. Furcht vor der Krankheit (Fear - disease)
9. Fehlanpassungsbelohnungen (Nonadaptive rewards)
10. Wahrgenommene Verwundbarkeit (Perceived vulnerability)
11. Wahrgenommene Schwere (Perceived severity)

---

4. Tabelle

Antwortskala: 7-stufige Likert-Skala (1 = „stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 = „stimme voll und ganz zu“)

Konstrukt	Item	Quelle
Nutzungsabsicht	Ich beabsichtige, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung zu nutzen.	neu formuliert
Nutzungsabsicht	Ich plane, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung in Anspruch zu nehmen.	neu formuliert
Nutzungsabsicht	Ich werde versuchen, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung einzusetzen.	neu formuliert
Einstellung zum KI-System	Ich halte den Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung für eine gute Idee.	neu formuliert
Einstellung zum KI-System	Ich finde die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung positiv.	neu formuliert
Einstellung zum KI-System	Ich beurteile ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung als nützlich.	neu formuliert
Einstellung zum KI-System	Für mich ist ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung etwas Vorteilhaftes.	neu formuliert
Einstellung zum KI-System	Ich stehe dem Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung aufgeschlossen gegenüber.	neu formuliert
Furcht vor dem KI-System	Der Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung macht mir Angst.	neu formuliert
Furcht vor dem KI-System	Ich fühle mich unwohl bei dem Gedanken an ein	neu

	KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung.	formuliert
Furcht vor dem KI-System	Die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung beunruhigt mich.	neu formuliert
Wahrgenommene Antworteffizienz	Ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung ist wirksam zur Bewältigung meiner Erkrankung.	neu formuliert
Wahrgenommene Antworteffizienz	Ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung hilft dabei, meine gesundheitlichen Probleme zu reduzieren.	neu formuliert
Wahrgenommene Antworteffizienz	Durch ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung verbessert sich die Qualität meiner medizinischen Versorgung.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich habe die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung genutzt wird.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Die Steuerung der Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung liegt in meiner eigenen Hand.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich besitze die nötigen Ressourcen, um ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung zu nutzen.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Es fällt mir leicht, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung zu verwenden.	neu formuliert
Wahrgenommene Normen	Personen, die mir wichtig sind, befürworten ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung.	neu formuliert
Wahrgenommene Normen	Mein soziales Umfeld erwartet von mir, dass ich ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung nutze.	neu formuliert
Wahrgenommene Normen	Wichtige Bezugspersonen halten ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung für sinnvoll.	neu formuliert
Wahrgenommene Normen	Die Menschen in meinem Umfeld würden es begrüßen, wenn ich ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung verwende.	neu formuliert
Einstellung zur Krankheit	Ich halte eine aktive Auseinandersetzung mit meiner Erkrankung im Rahmen meiner Behandlung für sehr wichtig.	neu formuliert
Einstellung zur Krankheit	Für mich hat die gezielte Behandlung meiner	neu

	Erkrankung eine hohe Priorität.	formuliert
Einstellung zur Krankheit	Ich sehe es positiv, meine Erkrankung im Rahmen meiner Behandlung konsequent anzugehen.	neu formuliert
Furcht vor der Krankheit	Meine Erkrankung und deren Verlauf machen mir Angst.	neu formuliert
Furcht vor der Krankheit	Ich mache mir große Sorgen bezüglich der gesundheitlichen Folgen meiner Erkrankung.	neu formuliert
Furcht vor der Krankheit	Der Gedanke an meine Erkrankung löst bei mir ein Gefühl der Verunsicherung aus.	neu formuliert
Fehlanpassungsbelohnungen	Wenn ich bei meiner Behandlung auf ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem verzichte, spare ich mir Aufwand.	neu formuliert
Fehlanpassungsbelohnungen	Behalte ich meine gewohnte Behandlungsform ohne ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei, fühle ich mich bequemer.	neu formuliert
Fehlanpassungsbelohnungen	Der Verzicht auf ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung gibt mir ein vertrautes Gefühl.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich halte das Risiko für hoch, dass sich meine Erkrankung ohne angemessene Behandlung verschlechtert.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Für mich besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, von gesundheitlichen Komplikationen betroffen zu sein.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich fühle mich anfällig für negative gesundheitliche Entwicklungen bezüglich meiner Erkrankung.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass meine Gesundheit ohne wirksame Maßnahmen beeinträchtigt wird.	neu formuliert
Wahrgenommene Schwere	Meine Erkrankung hat schwerwiegende Auswirkungen auf mein tägliches Leben.	neu formuliert
Wahrgenommene Schwere	Eine Verschlechterung meiner Erkrankung würde meine Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.	neu formuliert
Wahrgenommene Schwere	Ich schätze die gesundheitlichen Folgen meiner Erkrankung als gravierend ein.	neu formuliert
Wahrgenommene Schwere	Meine Erkrankung stellt ein ernsthaftes Problem für mein langfristiges Wohlbefinden dar.	neu formuliert
Wahrgenommene Schwere	Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch meine Erkrankung empfinde ich als gravierend.	neu formuliert